

История гигиены труда

- Гиппократ (460-377 гг. до н.э.) изучал свинцовые интоксикации;
- Парацельс (XV-XVI вв.) описал заболевание "Чахотка горняков, каменотесов, литейщиков";
- Б. Рамаццини "Рассуждения о болезнях ремесленников", 1700 г.;
- А.Н. Никитин "Болезни рабочих с указанием предохранительных мер", 1847 г., описано 120 профессий;
- Ф.Ф. Эрисман (1842-1915): изучал условия труда рабочих предприятий Московской губернии, написал книгу "Профессиональная гигиена или гигиена умственного и физического труда", 1877 г.;
- Д.П. Никольский "Курс профессиональной гигиены", 1907 г.;
- Кодекс законов о труде, 1918 г.;
- А.П. Доброславин (1842-1889) изучал условия труда на табачных фабриках, в шахтах, кессонах, описал пневмокониозы различной этиологии, симптомы профессиональных отравлений сероводородом и свинцом;
- В.А. Левицкий (1867-1936) изучал ртутные отравления в фетровом производстве, влияние лучистого тепла, профессиональный рак, действие на организм радия и продуктов его распада;
- И.М. Сеченов (1829-1905) – "Очерк рабочих движений человека".

Виды труда

(делятся по уровню затрат физической энергии)

1. *физический труд*
характеризуется
преобладанием
мышечной активности.

1. *умственный труд*
характеризуется
преобладанием
умственной и творческой
деятельности.

Формы трудовой деятельности

- Формы труда, требующие значительной мышечной активности.
- Групповые формы труда (конвейеры).
- Формы труда, связанные с полуавтоматическим и автоматическим производством.
- Формы труда, связанные с дистанционным управлением производственными процессами и механизмами.
- Формы интеллектуального (умственного) труда.

Формы трудовой деятельности

Формы труда, требующие значительной мышечной активности.

Профессии землекопа, грузчика, каменщика, докера-механизатора и т.д. . Эти формы труда носят название *общей физической работы*, в трудовую деятельность вовлекается более $\frac{2}{3}$ всей мышечной массы человека. Они требуют повышенных энергозатрат - 4000-6000 ккал (16,7-25,8 МДж) в сутки.

Неэффективность физического труда сопряжена с высоким напряжением физических сил человека, потребностью в длительном (до 50 % рабочего времени) отдыхе.

Механизированные формы труда.

Токарные, слесарные, рихтовочные и другие работы. Энергозатраты при такой работе колеблются в пределах 3000- 4000 ккал (12,5-16,7 МДж) в сутки.

Уменьшается роль крупных мышц и увеличивается доля участия в работе более мелких мышечных групп, возрастает значимость скорости и точности движений, требуется накопление специальных знаний и навыков, необходимых для управления различными инструментами, механизмами, станками и т.д.

Формы труда, связанные с полуавтоматическим и автоматическим производством.

При полуавтоматическом производстве человек выключается из процесса непосредственной обработки предмета труда. Характерные черты этого вида работ - монотонность, повышенный темп и ритм работы, утрата творческого начала (штамповщика, шлифовщика, швей-мотористки).

При автоматическом производстве, человека переходит к непосредственному управлению. Задача работника сводится к обеспечению бесперебойной работы автоматов, станков, механизмов.

Физиологической особенностью автоматизированных форм труда являются готовность работника к действию и связанная с ней быстрота реакции по устранению возникающих неполадок. Такое функциональное состояние «оперативного ожидания» бывает различным по степени утомительности в зависимости от отношения к работе, срочности необходимого действия, ответственности предстоящей работы и т.д.

формы труда, связанные с дистанционным управлением производственными процессами и механизмами.

Пример формы дистанционного управления - профессии крановщиков, водителей наземного транспорта, трактористов, комбайнеров.

Другая форма дистанционного управления основана на создании пультов, оснащенных сенсорным полем информации. Пример - различные профессии операторов химических производств, энергодобывающих предприятий и т.д.

Формы интеллектуального (умственного) труда.

Исполнительский. Реализация принятого решения работником осуществляется через заведомо известные стереотипные действия и не сопровождается дефицитом времени. К такому труду относится деятельность лаборантов, медицинских сестер и др.

Управленческий. К этому виду деятельности относятся руководители учреждений, предприятий, фирм, корпораций.

чрезмерный объем информации,
дефицит времени для ее переработки,

повышенная личная ответственность за принятие решений,
периодическим возникновением конфликтных ситуаций.
необходимость решать различные по степени сложности задачи

распределять задания и проводить контроль за их выполнением;

многочисленные коммуникационные связи.

Операторский. Этот вид деятельности связан с управлением машин, станков, различных автоматизированных и механизированных линий, систем и т.д.

К таким профессиям относятся операторы автоматизированных линий и систем, телефонисты, телеграфисты, железнодорожные и авиационные диспетчеры.

Работа отличается ответственностью и высоким нервно-эмоциональным напряжением.

Творческий.

значительного объема памяти,
специальной предварительной
подготовки и квалификации,
напряжения внимания,
нервно-эмоционального напряжения.

Это труд научных работников, писателей,
композиторов, артистов, художников,
архитекторов, конструкторов. Такие
работники должны иметь хорошую
память, инициативность, способность к
длительному сосредоточению
внимания.

Труд преподавателей и медицинских работников отличается постоянными контактами с людьми, повышенной ответственностью, часто дефицитом времени и информации для принятия окончательного решения.

Труд учащихся и студентов, характеризуется напряжением основных психических функций - памяти, внимания (особенно его концентрация и устойчивость), восприятия.

учебный процесс сопровождается стрессовыми ситуациями во время контрольных работ, зачетов, экзаменов и при подготовке к ним.

физические нагрузки, обусловленные занятиями физкультурой, в спортивных секциях.

Вследствие неправильно организованной работы могут возникать невроты, нарушения сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем.

Вредным производственным фактором называется фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях может вызвать:

- профессиональное заболевание;
- временное или стойкое снижение трудоспособности;
- повышение частоты соматических и инфекционных заболеваний;
- нарушение здоровья потомства.

По определению Международной организации труда (МОТ), профессиональное заболевание - это заболевание, развившееся в результате воздействия факторов риска, обусловленных трудовой деятельностью.

В настоящее время нет общепринятой классификации профессиональных заболеваний. Каждая страна - член МОТ - устанавливает свой перечень профессиональных заболеваний и определяет меры их профилактики и социальной защиты пострадавших.

Основные критерии, позволяющие определить профессиональное происхождение заболеваний, следующие:

- наличие связи с конкретным производственным фактором (например, пыль - пневмокониоз);
- наличие причинно-следственных связей с производственной средой и профессией;
- превышение среднего уровня заболеваемости у определенной профессиональной группы лиц по сравнению со всем населением.

К вредным производственным факторам относятся:

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Физические:

- микроклиматические - температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение;
- неионизирующие излучения:
 - электромагнитные, электростатические, постоянные магнитные поля, электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц);
 - электромагнитные излучения радиочастотного диапазона и оптического диапазона;
- ионизирующие излучения;
- производственный шум, ультразвук, инфразвук, вибрация;
- аэрозоли;
- освещение;
- электрически заряженные частицы воздуха .

К вредным производственным факторам относятся:

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Химические, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые химическим синтезом, для контроля которых используют методы химического анализа.

Биологические - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в препаратах, патогенные микроорганизмы.

Факторы трудового процесса (обстоятельства, условия, определяющие трудовой процесс: тяжесть труда и напряженность труда).

1. *Тяжесть труда* - характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его жизнедеятельность.
2. *Тяжесть труда определяется:* физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза вручную; количеством стереотипных рабочих движений за смену; рабочей позой; степенью наклона корпуса; перемещением в пространстве, обусловленным технологическим процессом.

1. *Напряженность труда* - характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.
2. *Показателями, характеризующими напряженность труда, являются интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы.*

Классификация условий труда.

В соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-05» все условия труда подразделяются на 4 класса:

оптимальные,
допустимые,
вредные
опасные.

Оптимальные условия труда (1-й класс) - такие условия, при которых не только сохраняется здоровье работающих, но и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы условий труда установлены только для параметров микроклимата и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за оптимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения.

Допустимые условия труда (2-й класс) характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма исчезают за время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.

1-й и 2-й классы условий труда относятся к *безопасным* для работающих.

Вредные условия труда (3-й класс) характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающих и/или их потомство.

PEDIATRIC
UNIVERSITY

3-й класс 1-я степень (3.1) - условия труда, которые вызывают функциональные изменения, исчезающие при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами и увеличивающие риск повреждения здоровья.

3-й класс 2-я степень (3.2) - условия труда, которые могут вызывать стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению производственно обусловленной заболеваемости, появлению начальных признаков или легких форм профессиональных заболеваний, возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 лет работы и более).

3-й класс 3-я степень (3.3) - условия труда, воздействие которых приводит к развитию, легких и среднетяжелых профессиональных болезней, росту хронической патологии, повышенную заболеваемость.

3-й класс 4-я степень (3.4) - условия труда, в которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний и высокая заболеваемость с временной утратой трудоспособности.

Опасные (экстремальные) условия труда (4-й класс) характеризуются уровнем производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в том числе тяжелых форм.

Классификация производственной пыли:

- По происхождению - органическая (растительная, животная, полимерная); неорганическая (минеральная, металлическая); смешанная.
- По способу образования - аэрозоли дезинтеграции, образующиеся при размоле и обработке твердых тел; аэрозоли конденсации, получающиеся в результате конденсации паров металлов и неметаллов (шлаков).
- По дисперсности - *видимая* (частицы более 10 мкм); *микроскопическая* (от 0,1 до 10 мкм); *ультрамикроскопическая* (менее 0,1 мкм).

Действие пыли

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- Неспецифическое действие
гнойничковые заболевания кожи, дерматиты, конъюнктивиты; неспецифические заболевания органов дыхания (риниты, фарингиты, пылевые бронхиты, пневмония); рак легких (от воздействия канцерогенной пыли, например сажи, асбеста).
- Специфическое действие
развитие пневмокониозов (от воздействия фиброгенной пыли).

Пневмокониозы. Хронические профессиональные пылевые заболевания легких, характеризующиеся развитием фиброзных изменений в результате длительного ингаляционного действия фиброгенных производственных аэрозолей.

Силикоз (горнорабочие рудников, рабочие литейных цехов, рабочие производства огнеупорных материалов и керамических изделий).

атрофия мерцательного эпителия дыхательных путей

задержка пыли в альвеолах.

в интерстициальной ткани легких развивается первичный реактивный склероз с прогрессирующим течением.

наибольшей агрессивностью обладают частицы размером 1-2 мкм

три формы силикоза: узелковую, интерстициальную и опухолевидную (узловую).

Осложнения силикоза: легочное сердце, легочно-сердечная недостаточность, пневмония, обструктивный бронхит, бронхиальная астма, бронхэктатическая болезнь. Силикоз нередко осложняется туберкулезом.

Мероприятия по профилактике направлены

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- на ликвидацию причин образования и распространения пыли, на изменение технологического процесса,
- Использование мер личной профилактики (СИЗ).
- Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.
- Целесообразны ингаляции, облучение УФ-лучами в субэритемной дозе.
- ПДК кремния диоксида в воздухе рабочей зоны зависит от вида, состава и содержания в пыли: более 70 %, от 10 до 70 %, от 2 до 10 % - и составляет от 1 до 4 мг/м³.

Шум - это совокупность звуков различной интенсивности и частоты, беспорядочно изменяющихся во времени, возникающих в условиях производства и неблагоприятно воздействующих на организм.

Для гигиенической оценки шума используют звуковой диапазон частот от 45 до 11 000 Гц, включающий 9 октавных полос со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц.

В зависимости от характера спектра выделяют следующие шумы:

широкополосные с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

тональные, в спектре которых имеются выраженные тоны.

По временным характеристикам различают шумы:

постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБА;

непостоянные, уровень шума которых за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не менее чем на 5 дБА.

- колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во времени;

- прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется (на 5 дБА и более);

- импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый из которых имеет длительность менее 1 с, при этом уровни звука различаются не менее чем на 7 дБ.

Действие производственного шума на организм

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Нейро-сенсорная тугоухость. Механизм нарушения слуха заключается в развитии атрофических процессов в нервных окончаниях кортиева органа.

Астеновегетативные нарушения.

жалобы на головную боль, повышенную утомляемость, нарушение сна, снижение памяти, раздражительность, сердцебиение.

Дисфункция желудка.

Объективно наблюдаются удлинение латентного периода рефлексов, изменение дермографизма, лабильность пульса, повышение артериального давления и т.д.

Снижение иммунологической реактивности и общей резистентности.

СИЗ и организационные мероприятия:

Наушники, вкладыши («беруши»), антифоны, шлемофоны снижают проникновение шума в ухо на 10-50 дБ.

рациональное сочетание труда и отдыха.

Медико-профилактические мероприятия:

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (терапевт, оториноларинголог, по показаниям невропатолог, аудиометрические исследования, контроль артериального давления).

К работе в шумных условиях не допускаются лица, имеющие:• стойкое понижение слуха;• отосклероз и другие хронические заболевания уха;• нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии, в том числе болезнь Меньера.

СИЗ и организационные мероприятия:

Наушники, вкладыши («беруши»), антифоны, шлемофоны снижают проникновение шума в ухо на 10-50 дБ.

рациональное сочетание труда и отдыха.

Медико-профилактические мероприятия:

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (терапевт, оториноларинголог, по показаниям невропатолог, аудиометрические исследования, контроль артериального давления).

К работе в шумных условиях не допускаются лица, имеющие:• стойкое понижение слуха;• отосклероз и другие хронические заболевания уха;• нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии, в том числе болезнь Меньера.

Вибрация - механические колебательные движения системы с упругими связями, передающиеся непосредственно телу человека или отдельным его частям.

Вибрация по способу передачи человеку подразделяется:

общую - передается через опорные поверхности тела и распространяется по всему организму

локальную - передается через руки, ограниченные участки тела.

Вибрация характеризуется частотой - числом колебаний в 1 с (герц), виброскоростью (м/с) и виброускорением (м/с^2) или их логарифмические уровни (децибел).

Клиническая картина вибрационной болезни:

ангиодистонический,
ангио-спастический синдромы,
вегето-сенсорная полиневропатия.

Характерные жалобы - боли, парестезии, зябкость конечностей, приступы побеления или синюшности пальцев рук при охлаждении, снижение силы в руках, головная боль, повышенная утомляемость, нарушение сна. При воздействии общей вибрации преобладают жалобы на боль и парестезии в ногах, пояснице, головную боль, головокружение. При длительном (15-20 лет) воздействии общей вибрации часто наблюдаются дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника, осложненные формы поясничного остеохондроза.

технические мероприятия:

внедрению дистанционного управления
виброопасными процессами,
усовершенствованию ручных инструментов путем
уменьшения вибрации в источнике ее
образования и по пути распространения,
установке виброгасящих амортизаторов под станки,
оборудование и сиденья на рабочих местах.

Организационные мероприятия:

Эффективны обеспечение рационального режима
труда и отдыха, организация комплексных бригад
и овладение смежными профессиями, что
позволяет уменьшить время контакта рабочих с
вибрацией.

СИЗ: Из средств индивидуальной защиты
рекомендуются рукавицы с пробковой
прокладкой на ладонях при локальной вибрации
и специальная обувь на толстой эластичной
подошве при общей вибрации.

Классификация промышленных веществ по характеру действия на организм (классификация Гендерсона и Хаггарда)

1. Удушающие: азот, водород, гелий, окись углерода, синильная кислота.
2. Раздражающие вещества, вызывающие раздражение слизистой оболочки дыхательных путей или непосредственно легких.
3. Летучие наркотики и родственные им вещества, оказывают острое действие на нервную систему, вызывая наркотическое опьянение.
4. Неорганические и металлоорганические соединения. В эту группу отнесены вещества (ртуть, свинец, фосфор, металлоорганические соединения, мышьяковистый и фосфористый водород и др).

ПДК – понимается такая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, которая при ежедневной (кроме выходных) работе в течение 8 часов в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего или последующего поколений.

ОБУВ (ориентировочно безопасный уровень воздействия). Он определяется путем расчета по физико-химическим свойствам интерполяции и экстраполяции рядов, близких по строению соединений или по показателям острой токсичности.

Виды действия ядов

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Комбинированное – это одновременное или последовательное действие на организм нескольких ядов при одном и том же пути поступления.

- аддитивное – суммирование эффектов, индуцированных комбинированным воздействием. Суммарный эффект смеси равен сумме эффектов действующих компонентов.
- потенцированное – усиление эффекта.
- антагонистическое – эффект комбинированного воздействия менее ожидаемого при простой суммации.
- независимое – комбинированный эффект не отличается от изолированного действия каждого яда.

Сернистый газ (сернистый ангидрид), SO_2 обладает резким удушающим запахом, хорошо растворяется в воде.

При *острых* и *подострых* формах отмечается поражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей (отек, усиление отделения слизи), кашель, чувство удушья и жжения, слезотечение, резь в глазах. При *тяжелых* формах отравления могут возникнуть бронхиолит и отек легких. При воздействии высоких концентраций возможны рефлекторный спазм голосовых связок и паралич дыхания.

При *хронической* интоксикации развиваются атрофические процессы в слизистой оболочке верхних дыхательных путей, риниты, бронхиты, евстахииты, конъюнктивиты, разрушаются зубы, анемия, снижается количество нейтрофилов, нарушается углеводный и белковый обмен. Отмечают угнетение окислительных процессов в головном мозге, печени, селезенке, мышцах, у женщин - нарушение менструального цикла. При хроническом отравлении развиваются трахеобронхит, эмфизема, пневмоклероз.

Особенности условий труда медицинских работников

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Заболеваемость медицинского персонала

46% - заболевания органов дыхания

14% - болезни сердечно-сосудистой системы

5-6% - болезни нервной, пищеварительной,
костно-мышечной систем.

Основные факторы, приводящие к профессиональным заболеваниям медицинских работников

Биологический фактор – 73% (ВИЧ инфекция, микоплазмозы, кампилобактериоз, туберкулез, сифилис, малярия, гепатиты)

Высокоактивные лекарственные препараты – 16%

Лекарственные вещества – 11%

Особенности условий труда врачей стоматологов

- Повышенная нервно-эмоциональная напряженность
- Зрительное напряжение
- Вынужденная рабочая поза
- Нерациональное освещение
- Опасность передачи инфекции
- Контакт с аллергенами и токсическими веществами
- Шум, вибрация
- Пыль

Мероприятия по предупреждению вредного действия условий труда

PEDIATRIC
UNIVERSITY

1. Законодательные
2. Контролирующие
3. Организационные
4. Санитарно-технические и технологические
5. Медико-профилактические
6. СИЗ

Законодательные, правовые и нормативные акты

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Конституция РФ.

В главе 1

ст. 7 п. 2, «в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

В главе 2

ст. 37 п. 3 : «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены...»;

п. 5: «Каждый имеет право на отдых.».

ст. 41. «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений».

«Соккрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом».

ФЗ № 52-ФЗ (1999 г.) «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии»;
№ 183-ФЗ (1999 г.) «Об основах охраны
труда в Российской Федерации»;
Трудовой кодекс Российской Федерации
№ 197-ФЗ (2001 г.)
СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к
условиям труда"

Организационные мероприятия

PEDIATRIC
UNIVERSITY

оптимизация режима труда, ритма
трудового процесса,
организация правильного чередования
рабочих операций,
обеспечение производственной эстетики,
оптимальной планировки рабочих
помещений.

Санитарно-технические мероприятия

PEDIATRIC
UNIVERSITY

способствуют предупреждению неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов.

Промышленная вентиляция остается существенной мерой для ряда производств и некоторых технологических процессов и нередко играет главную роль в борьбе с неблагоприятными факторами производственной среды.

Все существующие системы промышленной вентиляции могут быть классифицированы по следующим основным особенностям своего устройства:

- по побудителю движения воздуха (естественная и искусственная вентиляция);
- по месту действия (общая и местная вентиляция);
- по назначению (приточная и вытяжная вентиляция).

Производственное освещение.

Производственные помещения и рабочие поверхности освещают **естественным и искусственным светом.**

Уровни освещенности нормируются и предполагают наиболее выгодное соотношение яркости рабочих и окружающих поверхностей, отсутствие резких теней и чрезмерной яркости (блескости), устойчивый режим осветительной установки, устранение стробоскопического эффекта, ощущения множественных мнимых изображений движущегося предмета.

Естественное освещение производственных помещений осуществляется либо через окна в стенах здания, либо через отверстия для верхнего света - фонари.

Естественным светом обеспечивается в основном общее освещение, искусственным - общее, местное и комбинированное.

Средства индивидуальной защиты.

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Индивидуальные защитные приспособления, используемые лично самими работниками предприятий для предохранения от тех или иных профессиональных вредностей.

К СИЗ относятся противогазы, респираторы, антифоны, защитные очки, спецодежда и спецобувь.

Лечебно-профилактические мероприятия

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Медицинские осмотры - контрольное медицинское изучение состояния здоровья работников.

Предварительные медицинские осмотры ставят своей целью не допускать на работу, связанную с производственными вредностями, лиц, имеющих нарушения здоровья, которые могут усилиться под влиянием специфических производственных вредностей.

Периодические медицинские осмотры проводят с целью динамического наблюдения за состоянием здоровья работающих в условиях воздействия вредных профессиональных факторов.

Список работников, подлежащих
медицинскому осмотру,
согласовывается с федеральным
государственным учреждением
здравоохранения - центром гигиены и
эпидемиологии.

Перечень специалистов, участвующих в
медицинских осмотрах, необходимых
лабораторных и функциональных
исследований, проводимых лечебно-
профилактическими учреждениями,
осуществляется в соответствии с
действующими приказами
Минздравсоцразвития.